

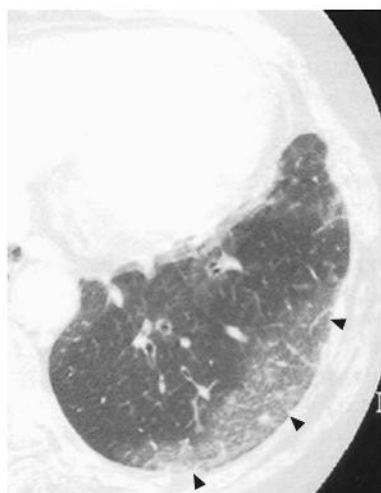


図1 特発性LIP症例胸部CT
 [日本呼吸器学会びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン作成委員会(編):特発性間質性肺炎診断と治療の手引き2022(改訂第4版), 南江堂, p119, 2022より許諾を得て転載]

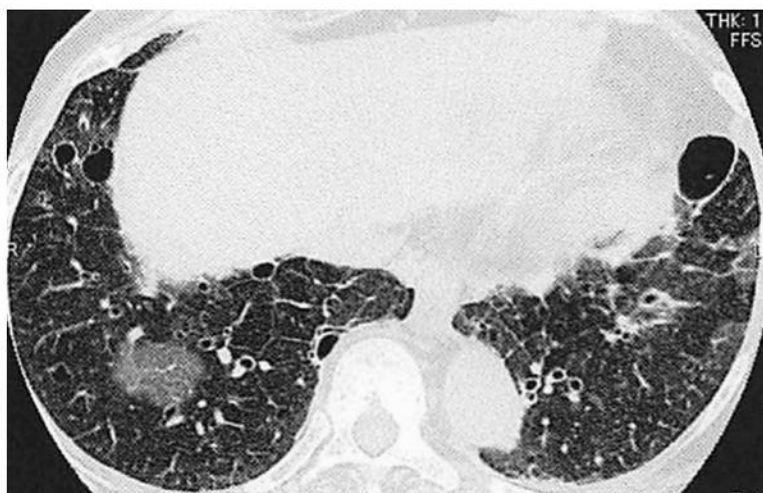


図2 特発性LIP症例胸部CT
 [日本呼吸器学会びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン作成委員会(編):特発性間質性肺炎診断と治療の手引き2022(改訂第4版), 南江堂, p120, 2022より許諾を得て転載]

表1 特発性LIPの組織学的特徴

A. 鍵となる組織像
1. びまん性の間質への浸潤病変
2. 肺泡隔壁を主体に病変は分布する
3. 浸潤細胞の主体はTリンパ球, 形質細胞, マクロファージ
4. mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) の過形成をしばしば伴う
B. 認めない所見
1. 悪性リンパ腫に特徴的とされる, 気管支血管束, 胸膜, 小葉間隔壁などのリンパ路に沿った病変
2. 著明な器質化肺炎像
3. Dutcher body
4. 形質細胞の軽鎖のモノクローナリティ*
5. 広範な胸膜浸潤やリンパ節浸潤
6. 壊死性肉芽腫

*リンパ球の免疫グロブリン(H鎖, L鎖)やT細胞受容体の遺伝子再構成のないことをPCRやサザンブロットにて確認し, モノクローナルな増殖を否定する。

[American Thoracic Society/European Respiratory Society: Am J Respir Crit Care Med 165: 277, 2002より作成]

治療と予後

一般的に, 治療には副腎皮質ステロイド薬が使用され, 半数は治療に反応するとされているが, cyclophosphamideなどの免疫抑制薬を用いた報告もある¹⁾。15年間で15例のLIPを解析した報告では, LIP全体の中央生存期間は11.5年, 15例中3例の特発性LIP症例では2例は10年以上生存していた⁷⁾。しかし全体的に症例数が少なく, 有効性や予後は正確には不明である。

2

特発性胸膜肺実質線維弾性症 idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis

到達目標

- ◆ 診断指針を概説できる
- ◆ 画像の特徴を説明できる
- ◆ 呼吸生理学的な特徴を説明できる
- ◆ IPFとの相違点を説明できる

病態・疫学

類似の病態を1992年に網谷らは特発性上葉限局型